

Anamnèse et Examen Clinique Complet - Guide ECOS

■ Structure de l'Anamnèse Générale

1. Anamnèse Actuelle et Caractérisation de la Plainte

Pour une Douleur (LIRQTFS)

- Localisation
- Irradiation
- Rythme/Intensité (y.c. fluctuation de l'intensité, échelle 0-10)
- Qualité (caractérisation: brûlure, piquûre, serrement, etc.)
- Timing (début et évolution dans le temps, aigu vs progressif)
- Facteurs modifiants (soulageants et aggravants)
- Symptômes associés

Pour Autres Plaintes

- Fréquence, timing, durée
- Caractéristiques** (couleur, texture, quantité)
- Présence de sang
- Facteurs déclenchants/modifiants

Questions Bonus

- "Avez-vous déjà eu un épisode similaire?"
- "Avez-vous déjà fait des examens/traitements pour cela?"
- "Qu'est-ce qui vous inquiète/dérange le plus?"
- "Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous craignez?"

"Depuis combien de temps avez-vous ce problème?"

"Pouvez-vous décrire l'aspect de...?"

"Avez-vous remarqué du sang?"

"Qu'est-ce qui déclenche ou améliore vos symptômes?"

"Avez-vous déjà ressenti une douleur similaire auparavant?"

"Quels examens ou traitements avez-vous déjà eus pour ce problème?"

"Quelle est votre principale préoccupation concernant vos symptômes?"

2. Questions Spécifiques au Système Concerné

(Voir sections détaillées par système)

3. Questions Générales - Symptômes B

- Fièvre** (température précise, méthode, timing, frissons)
- Sudations nocturnes
- Perte de poids** (quantifiée, délai)
- Fatigue/Asthénie
- Anorexie

"Avez-vous eu de la fièvre? L'avez-vous mesurée? Quelle était la température maximale?"

"Avez-vous des sueurs nocturnes nécessitant de changer de vêtements?"

"Avez-vous perdu du poids? Combien de kilos en combien de temps?"

"Comment est votre niveau d'énergie? Plus fatigué(e) que d'habitude?"

"Avez-vous perdu l'appétit? Mangez-vous moins qu'avant?"

4. Anamnèse par Système (Tête aux Pieds)

- Neuro**: céphalées, vertiges, troubles visuels
- Cardio**: palpitations, œdèmes, douleur thoracique
- Pneumo**: toux, dyspnée, expectorations
- Gastro**: douleurs, N/V, transit
- Urines**: fréquence, couleur, odeur, sang
- Sexuel**: partenaire, contraception, protection IST
- Ostéoarticulaire**: douleurs, raideur, gonflement

"Avez-vous des maux de tête? Des vertiges?"

"Ressez-vous des palpitations? Un gonflement des jambes?"

"Toussez-vous? Êtes-vous essoufflé(e)?"

"Comment est votre transit intestinal?"

"Avez-vous noté des changements urinaires?"

"Êtes-vous sexuellement actif(ve)?"

"Avez-vous des douleurs articulaires?"

• Dermato**: changements cutanés	"Avez-vous remarqué des changements sur votre peau?"
5. Histoire Médicale Personnelle • ATCD médicaux et chirurgicaux** (diabète, HTA, dyslipidémie, IR) • Maladies récentes • Traitements** (y.c. automédication, pilule, plantes, vitamines) • Vaccination • Allergies	"Avez-vous des problèmes de santé connus? Diabète? Hypertension? Cholestérol?" "Avez-vous été malade ou hospitalisé récemment?" "Quels médicaments prenez-vous? Même sans ordonnance, vitamines, plantes?" "Vos vaccins sont-ils à jour? Date du dernier vaccin contre le tétanos?" "Avez-vous des allergies médicamenteuses? Alimentaires? Autres?"
6. Histoire Familiale Parents, fratrie, enfants - rechercher pathologies héréditaires • "Y a-t-il des maladies qui touchent plusieurs membres de votre famille?" • "Vos parents sont-ils en bonne santé? De quoi souffrent-ils?" • "Y a-t-il des antécédents de cancer, diabète ou maladie cardiaque dans votre famille?"	
7. Habitudes (TADADAVS) • T**abac • A**lcool • D**rogues • A**limentation • D**omicile et vie familiale (stress) • A**ctivité physique • V**oyage • S**exualité et profession (stress, risques)	"Fumez-vous? Combien de cigarettes par jour? Depuis quand?" "Consommez-vous de l'alcool? Quelle quantité par semaine?" "Avez-vous déjà consommé des substances? C'est une question purement médicale." "Comment est votre alimentation? Combien de repas par jour?" "Avec qui vivez-vous? Y a-t-il des sources de stress à la maison?" "Pratiquez-vous une activité physique? À quelle fréquence?" "Avez-vous voyagé récemment? Dans quels pays?" "Êtes-vous sexuellement actif? Quelle est votre profession?"
8. Questions de Clôture • "Y a-t-il encore quelque chose que j'aurais besoin de savoir pour mieux vous prendre en charge?" • "Avez-vous des questions pour moi?" • "Y a-t-il quelque chose qui vous préoccupe et dont nous n'avons pas parlé?" • "Comment vous sentez-vous par rapport à notre discussion?" • "Y a-t-il autre chose que vous aimeriez me dire?" • "Avez-vous oublié de mentionner quelque chose d'important?"	
■ Examen Clinique par Système ♥■ Status Cardiovasculaire Anamnèse Spécifique • FRCV: tabac, LDL, diabète, HTA, ATCD familiaux, sédentarité • Symptômes: douleur thoracique, dyspnée, œdèmes, palpitations, syncope Examen Clinique **Inspection** • Recherche ICG (cyanose extrémités + langue) • Recherche ICD (turgescence jugulaire, OMI) • Observation mains (cyanose, endocardite, hippocratisme) • Asymétrie/déformation thorax • Anomalies cutanées (cicatrices, varices)	"Je vais regarder la coloration de vos extrémités." "Je vérifie s'il y a des signes de congestion." "Permettez-moi d'examiner vos mains." "Je vais observer votre thorax." "Je recherche d'éventuelles anomalies sur votre peau."

****Palpation****

- TRC (N < 2 secondes)
- Température cutanée (dos de la main, comparer D-G)
- FC sur 15 secondes (60 si irrégulier)
- FR
- Pouls: carotidien, brachial, radial, ulnaire, fémoral, poplité, tibial post, pédieux
- Frémitus et choc de pointe (décubitus latéral G si nécessaire)
- Reflux hépato-jugulaire (20 secondes)
- Œdèmes (godet?)

- TA ± hypotension orthostatique

****Auscultation****

- Carotidienne et fémorale
- 4 foyers cardiaques ± inspiration profonde
- Foyer mitral en décubitus latéral G (sténose mitrale?)
- Para-sternale G penché en avant en expiration

****Phrases de conclusion du status cardiovasculaire:****

- "B1B2 réguliers, sans souffle perçu."
- "Pouls périphériques présents et symétriques."
- "Pas d'œdème des membres inférieurs."
- "TRC inférieur à 2 secondes, extrémités chaudes."

Bruits Cardiaques

- B1: Fermeture valves AV, long et grave, apex
- B2: Fermeture valves A/P, court et aigu, base
- B3: Après B2, physiologique si jeune, sinon surcharge volumique
- B4: Avant B1, toujours pathologique (CMH)

Souffles

****Holosystoliques****

- IM: apex
- IT: tricuspide
- CIV: parasternal G, irradiation étendue

****Mésosystoliques****

- Sténose aortique: foyer aortique
- Sténose pulmonaire: foyer pulmonaire
- CMHO: parasternal G le long du sternum

****Diastoliques****

- IA: protodiastolique au foyer aortique
- Sténose mitrale: méso-télédiastolique avec click, apex

■ Status Pulmonaire

Anamnèse Spécifique

- Dyspnée**: NYHA, bruits particuliers, orthopnée, DPN
- Toux**: aiguë/subaiguë/chronique, productive, expectoration
- Hémoptysie**: volume, sang frais vs altéré
- Douleurs**: pleurales, thoraciques
- Ronflements/somnolence

"Je vais appuyer sur votre ongle pour vérifier la circulation."

"Je vérifie la température de votre peau."

"Je vais compter votre pouls."

"Je vais compter votre fréquence respiratoire."

"Je vais palper vos différents pouls. Cela ne devrait pas être douloureux."

"Pouvez-vous vous tourner sur le côté gauche?"

"Je vais appuyer doucement sur votre foie."

"Je vérifie s'il y a de l'œdème au niveau de vos chevilles."

"Je vais mesurer votre tension artérielle."

"Je vais écouter vos vaisseaux avec mon stéthoscope."

"Respirez normalement... Maintenant inspirez profondément et bloquez."

"Restez sur le côté gauche, je vais écouter votre cœur."

"Penchez-vous en avant et expirez complètement."

"aisselle G"

"xyphoïde"

"carotides"

"épaule G"

"Êtes-vous essoufflé au repos ou seulement à l'effort?"

"Votre toux est-elle sèche ou grasse? Depuis combien de temps?"

"Quelle quantité de sang? Rouge vif ou plutôt foncé?"

"La douleur augmente-t-elle quand vous respirez profondément?"

"Ronflez-vous? Êtes-vous fatigué durant la journée?"

Examen Patient Couché

Inspection

- Rechercher SDR (stridor, sibilance, mm. accessoires, cyanose)

- Signes d'hypoxémie (cyanose, hippocratisme)
- Signes d'hypercapnie (transpiration scalp, confusion)

- Mouvements respiratoires (abdominaux doivent prédominer)
- Mesure FR

****Phrases descriptives:**** ***"Patient eupnéique, pas de tirage, pas de mise en jeu des muscles accessoires."**

Palpation

- Zones douloureuses
- Aires ganglionnaires
- Ampliation thoracique (mains sur rebord inférieur côtes)

Percussion

- Délimitation poumons (D: matité hépatique, G: tympanisme gastrique)

- Percussion symétrique comparative

****Phrases descriptives:**** ***"Percussion symétrique, pas de matité anormale."**

Auscultation

- Bruit trachéal + 4 niveaux antérieurs + 2 latéraux, symétriquement

- Demander de tousser pour caractérisation

Phrases descriptives:

- "Murmure vésiculaire présent bilatéralement."
- "Pas de crépitants, pas de sibilants."
- "Hypoventilation basale droite."
- "Fins crépitants en bases."

Examen Patient Assis

Répéter inspection, palpation, percussion, auscultation face postérieure

Bruits Pulmonaires

- Physiologiques: murmure vésiculaire, bruit trachéo-bronchique
- Souffle tubaire: pneumonie
- Crépitants fins: alvéolite, fibrose, œdème
- Crépitants grossiers: sécrétions bronchiques
- Sibilants: obstruction/asthme
- Ronchis: bronchite/asthme

■ Status Abdominal

Quadrants

Hypochondre D/G, épigastrique, lombaire D/G, ombilical, iliaque D/G, sus-pubien

Anamnèse Spécifique

- Douleur**: caractérisation complète
- Transit**: fréquence, aspect selles, sang, mucus
- Input-output**: dernier repas, N/V, gaz, selles, urines
- Ictère**: urines foncées + selles décolorées
- ATCD chirurgie abdominale** (brides?)

Examen Clinique

Inspection

"Je recherche des signes de détresse respiratoire."

"Je vérifie l'oxygénation de vos tissus."

"Je recherche des signes d'accumulation de CO₂."

"J'observe votre respiration."

"Je vais compter votre fréquence respiratoire pendant une minute."

"Y a-t-il une zone douloureuse sur votre thorax?"

"Je vais palper vos ganglions."

"Respirez profondément, je vais sentir l'expansion de votre thorax."

"Je vais percuter votre thorax pour délimiter vos poumons."

"Je compare la sonorité des deux côtés."

"Respirez profondément par la bouche s'il vous plaît."

"Toussez fort pour moi."

"Où avez-vous mal exactement? Comment décririez-vous cette douleur?"

"À quand remonte votre dernière selle? Aspect normal?"

"Qu'avez-vous mangé dans les dernières 24h? Avez-vous vomi?"

"Avez-vous remarqué un jaunissement de la peau ou des yeux?"

"Avez-vous déjà été opéré du ventre?"

- Aspect général, asymétrie, voussure

- Anomalies cutanées, cicatrices, hernies
- Mouvements respiratoires et pulsatiles

****Phrases descriptives:**** ***"Abdomen plat, pas de cicatrice visible, pas de masse pulsatile."**

****Auscultation**** (avant palpation!)

- 4 quadrants, terminer par zone douloureuse
- Trajet aorte ± aa. rénales ± aa. iliaques (souffle?)

****Phrases descriptives:**** ***"Bruit hydroaériques présents, normaux en fréquence et tonalité."**

****Percussion****

- 4 quadrants

- Délimitation taille du foie (LMC)

****Phrases descriptives:**** ***"Tympanisme normal, matité hépatique physiologique."**

****Palpation****

- Superficielle (mise en confiance)

- Profonde (recherche masse)

- Défense-détente

- TR

****Phrases descriptives:****

- "Abdomen souple et dépressible."
- "Pas de défense, pas de détente."
- "Pas de masse palpable."
- "Foie non palpable, rate non palpable."

Examen des Organes

- Foie/VB**: palpation bimanuelle, signe de Murphy

- Rate**: palpation comme foie

- Appendice**: McBurney, Psoas, Rovsing

- Rein**: percussion loge rénale position assise

- Uretères**: palpation trajet (douleur?)

- Aorte**: palpation à 2 mains

- Hernies**: tousser/lever tête (réductible? strangulation?)

****Phrases descriptives:**** ***"Loges rénales libres et indolores, pas de contact lombaire."**

■ Status Neurologique

Anamnèse Spécifique

- Céphalées**: caractérisation +++, photo-phonophobie

- Troubles moteurs/sensitifs

- Vertiges, équilibre, syncopes, chutes

- Vision/audition

- Fonctions cognitives

- Incontinence

Nerfs Crâniens

- I Olfactif**: reconnaissance odeurs

- II Optique**: AV, champs visuels, pupilles, FO

- III,IV,VI Oculomoteurs**: poursuite oculaire, saccades

"Je vais examiner votre abdomen. Allongez-vous confortablement."

"Je recherche des anomalies visibles."

"J'observe les mouvements de votre abdomen."

"Je vais écouter les bruits de votre ventre."

"Je recherche d'éventuels souffles vasculaires."

"Je vais percuter votre abdomen dans les 4 quadrants."

"Je vais déterminer la taille de votre foie."

"Je commence par une palpation légère. Dites-moi si c'est douloureux."

"Je vais palper plus profondément. Respirez calmement."

"Détendez vos muscles abdominaux."

"Avec votre permission, un toucher rectal serait indiqué."

"Inspirez profondément... Stop!"** (Murphy)"

"Je vais palper votre rate."

"Je vais tester quelques points spécifiques."

"Je vais percuter vos loges rénales."

"Je palpe le trajet de vos uretères."

"Je vais palper votre aorte abdominale."

"Toussez fort / Levez la tête du lit."

"Vos maux de tête sont-ils accompagnés d'une sensibilité à la lumière ou au bruit?"

"Avez-vous remarqué une faiblesse ou des fourmillements quelque part?"

"Avez-vous des vertiges? Avez-vous fait des chutes récemment?"

"Avez-vous des troubles de la vue ou de l'audition?"

"Avez-vous des troubles de mémoire ou de concentration?"

"Avez-vous des pertes involontaires d'urine ou de selles?"

"Sentez-vous les odeurs normalement?"

"Regardez droit devant... Comptez mes doigts."

"Suivez mon doigt sans bouger la tête."

- V Trijumeau**: sensibilité visage, ATM, réflexe cornéen
- VII Facial**: mimique faciale
- VIII Vestibulo-cochléaire**: chuchotement, Weber, Rinné, Halmagyi
- IX,X Glosso-pharyngien/Vague**: déviation luvette, déglutition
- XI Accessoire**: lever épaules contre résistance
- XII Hypoglosse**: mouvements langue

****Phrases descriptives:****

- "Pupilles isocores, isoréactives."
- "Poursuite oculaire lisse sans nystagmus."
- "Pas d'asymétrie faciale."
- "Nerfs crâniens sans déficit."

Système Somato-sensoriel

- Toucher-piquer (yeux fermés!)

- Proprioception

- Pallesthésie (diapason)
- Température
- Stéréognosie/Graphesthésie

****Phrases descriptives:**** ***Pas de troubles de la sensibilité des voies longues.***

Réflexes (0 à 4+, N=2+)

- MS**: biceps (C5-C6), triceps (C7), brachio-radial (C6)

- MI**: quadriceps (L4), achilléen (S1)

- Cutanés**: abdominal, plantaire

****Phrases descriptives:****

- "ROT présents et symétriques."
- "Réflexe cutané plantaire en flexion bilatéralement."
- "Pas de signe de Babinski."

Système Moteur

- Inspection amyotrophie
- Force M0-M5

- Motilité fine (pianoter)

- Tonus (mobilisation passive)

****Phrases descriptives:****

- "Force 5/5 aux 4 membres."
- "Pas de déficit moteur focal."
- "Tonus normal, pas de spasticité."
- "Bouge les 4 membres spontanément."

Épreuves Cérébelleuses

- Romberg (talons joints, bras tendus, yeux fermés)
- Doigt-nez (yeux ouverts puis fermés)
- Talon-genou

- Rebond
- Marionnettes

****Phrases descriptives:****

- "Pas d'ataxie cérébelleuse."

"Sentez-vous ce contact? Des deux côtés pareil?"

"Montrez-moi vos dents. Fermez fort les yeux. Gonflez les joues."

"Répétez ce que je chuchote."

"Ouvrez grand et dites 'Ahhh'."

"Haussez les épaules contre ma résistance."

"Tirez la langue et bougez-la de gauche à droite."

"Fermez les yeux. Dites-moi quand vous sentez le contact."

"Les yeux fermés, dites-moi si je monte ou descends votre orteil."

"Sentez-vous les vibrations?"

"Est-ce chaud ou froid?"

"Qu'est-ce que je dessine dans votre main?"

"Je vais tester vos réflexes. Relâchez complètement votre bras."

"Détendez votre jambe, je vais tester vos réflexes."

"Je vais stimuler légèrement votre peau avec cet objet."

"Je vais examiner vos masses musculaires."

"Poussez contre ma main... Tirez vers vous... Plus fort!"

"Faites des mouvements de piano avec vos doigts."

"Détendez-vous complètement, je vais mobiliser vos membres."

"Talons joints, bras tendus... Fermez les yeux."

"Touchez mon doigt puis votre nez, rapidement."

"Posez votre talon sur le genou opposé et descendez le long du tibia."

"Poussez contre ma main... Je lâche!"

"Faites des mouvements de marionnettes, de plus en plus vite."

- "Coordination normale."
- "Romberg négatif."

Épreuves Fonctionnelles

- Lasèque (L5-S1) et inversé (L3-L4)
- Mingazzini (dos) et Barré (ventre)
- Bras tendus
- Gowers
- Marche (normale, pointe, talons)

Méningisme

- Causes: méningite, HSA
- Signes: raideur nuque, Kernig, Brudzinski, Jolt

****Phrases d'examen:****

- Raideur nuque
- Kernig

- Brudzinski

****Phrases descriptives:**** *******"Pas de raideur méningée, Kernig et Brudzinski négatifs."******

■ Status Ophtalmologique et ORL

Ophtalmologie

****Anamnèse****

- Timing/évolution symptômes
- Douleurs, sécrétions, rougeur
- Modifications AV, flashes, corps flottants, diplopie

****Examen****

- Inspection conjonctive (paupières)
- Éversion paupière supérieure
- Champs visuels (4 quadrants, chiffres)
- Oculomotricité (poursuite, saccades)
- Pupilles (réflexe photomoteur, accommodation)
- Acuité visuelle (près 40cm, loin, avec lunettes)
- Vision couleurs (Ishihara)
- Fond d'œil

ORL

****Anamnèse****

- O^{**}: otalgie, otorrhée, acouphènes, hypoacousie, vertiges
- R^{**}: rhinorrhée, épistaxis, odorat, obstruction
- L^{**}: dysphagie, odynophagie, dysphonie, tuméfactions

****Examen****

- Palpation cervicale (ganglions, thyroïde)
- Inspection buccale
- Laryngoscopie indirecte
- Inspection nez
- Otoscopie
- Acoumétrie (Weber, Rinné)

"Touchez votre poitrine avec votre menton."

"Je vais plier votre hanche puis étendre votre genou."

"Je vais fléchir votre nuque."

"Depuis quand avez-vous ces troubles visuels?"

"Avez-vous mal aux yeux? Des sécrétions? Une rougeur?"

"Voyez-vous des éclairs? Des mouches volantes? Double?"

"Je vais examiner vos yeux maintenant."

"Pouvez-vous regarder vers le bas pendant que je soulève votre paupière?"

"Combien de doigts voyez-vous sans bouger les yeux?"

"Suivez mon doigt uniquement avec vos yeux."

"Regardez droit devant, je vais éclairer vos yeux."

"Pouvez-vous lire cette ligne?"

"Quel chiffre voyez-vous sur cette planche?"

"Fixez un point au loin pendant que j'examine votre rétine."

"Avez-vous mal aux oreilles? Des écoulements? Des sifflements?"

"Le nez coule? Saignements? Difficultés à sentir les odeurs?"

"Difficultés à avaler? Douleurs? Changement de voix?"

"Je vais palper votre cou pour vérifier vos ganglions."

"Ouvrez grand la bouche et dites 'Ahhh'."

"Je vais examiner votre gorge avec ce miroir."

"Je vais regarder dans vos narines."

"Je vais examiner vos oreilles avec cet otoscope."

"Entendez-vous ce diapason des deux côtés?"

■ Status Locomoteur

GALS (Screening)

Anamnèse

1. Douleurs/raideur muscles, articulations, dos?
2. Habillage/déshabillage sans difficultés?
3. Escaliers sans difficultés?

Examen

- G**ait: marche, pointe/talon
- A**rms: épaules, mains, pro-supination
- L**egs: hanches, genoux
- S**pine: Schober, mobilité

Phrases descriptives: **"Marche normale, pas de boiterie, pas d'instabilité. "**

Examen Articulaire Détaillé

Épaule

- Inspection: asymétrie, amyotrophie
- Palpation: chaleur, douleur, os, muscles
- Mobilisation: F-E, Abd-Add, RE-RI
- Tests: Neer, Hawkins, Jobe, Lift-off

Coude

- Inspection: déformation, tuméfaction
- Palpation: épicondyles, olécrane, nerf ulnaire
- Mobilisation: F-E, pro-supination
- Tests: épicondylite latérale/médiale

Main/Poignet

- Inspection: déformations, axes
- Palpation: scaphoïde+++, tabatière anatomique
- Mobilisation: F-E, inclinaisons, doigts
- Tests: Finkelstein, Tinel, Phalen

Rachis

- Inspection: scoliose, cyphose, lordose
- Palpation: musculature para-vertébrale
- Mobilisation: F-E, inclinaisons, rotations
- Tests: Schober, Lasègue, FABER

Hanche

- Inspection: boiterie, asymétrie
- Palpation: pouls fémoral, ADP
- Mobilisation: F-E, Abd-Add, RE-RI
- Tests: FABER, Thomas, Trendelenburg

Genou

- Inspection: varus/valgus, amyotrophie
- Palpation: épanchement (glaçon), interligne
- Mobilisation: F-E
- Tests: laxité (tiroir, Lachman), ménisques (McMurray), rotule (Smilie)

Cheville/Pied

- Inspection: pied plat, déformations
- Palpation: pouls, malléoles, tendons
- Mobilisation: F-E, inversion-éversion
- Tests: Thompson (Achille)

"Avez-vous des douleurs ou raideurs dans les muscles, articulations ou le dos?"

"Avez-vous des difficultés pour vous habiller le matin?"

"Pouvez-vous monter et descendre les escaliers sans problème?"

"Marchez jusqu'au mur et revenez. Sur la pointe des pieds. Sur les talons."

"Mettez vos mains derrière la tête. Serrez le poing. Touchez chaque doigt avec le pouce."

"Pliez les genoux. Écartez les jambes."

"Penchez-vous pour toucher vos pieds. Inclinez-vous sur le côté."

■ Status Gynécologique

Anamnèse Spécifique

- Caractérisation plaintes
- Grossesse (β-hCG systématique!)
- Seins: masse, écoulement, rougeur, ATCD
- Cycle menstruel: DDR, régularité, plaintes
- Contraception

Examen des Seins

Position Assise

- Inspection: asymétrie, rétractions, bosses
- Traction musculaire (mains sur hanches)
- Mobilité (mains derrière tête)
- Palpation 4 quadrants + prolongement axillaire

Position Couchée

- Palpation centripète
- Palpation quadrillage
- Recherche écoulement

Examen Génital

- Installation (vessie vide, information+++)
- Inspection OGE
- Palpation glandes (para-urétrales, Bartholin)
- Examen au spéculum
- Palpation bimanuelle utérus
- Palpation recto-vaginale

■ Status Urologique

Anamnèse Spécifique

Haut Appareil (reins, urètres)

- Douleurs lombaires, fièvre, hématurie

Bas Appareil (vessie, prostate)

- Obstruction**: dysurie, latence, jet affaibli, miction 2 temps
- Irritation**: nycturie, pollakiurie, impériosité

- Incontinence**: urgence vs effort

Examen

- Palpation/percussion loges rénales
- Palpation vessie
- TR (prostate)

- Palpation testicules

- Transillumination si nécessaire

■■■ **Torsion testiculaire**: douleur brutale, position horizontale, Prehn négatif, perte réflexe crémasterien

■ Status Pédiatrique

Anamnèse Spécifique

Identique adulte + :

"Je vais examiner vos seins maintenant. Est-ce acceptable pour vous?"

"Mettez vos mains sur vos hanches et poussez fort."

"Levez les bras au-dessus de la tête... Maintenant placez-les derrière la tête."

"Je vais palper chaque quadrant. Dites-moi si vous ressentez une douleur."

"Avez-vous vidé votre vessie? Je vais vous expliquer chaque étape."

"Je vais d'abord examiner la région externe."

"Je vais palper doucement les glandes. Prévenez-moi si c'est douloureux."

"Je vais insérer le spéculum. Respirez profondément et détendez-vous."

"Je vais maintenant examiner votre utérus avec deux mains."

"Si nécessaire, je procéderai à un examen recto-vaginal."

"Avez-vous des douleurs dans le dos? Du sang dans les urines?"

"Difficultés pour démarrer la miction? Jet faible?"

"Combien de fois urinez-vous la nuit? Besoins urgents?"

"Des fuites urinaires? À l'effort ou par urgence?"

"Je vais percuter vos fosses lombaires."

"Je vais palper votre vessie au niveau du pubis."

"Un toucher rectal serait indiqué, nous le ferons plus tard."

"Je dois examiner vos testicules, est-ce acceptable?"

"Je vais éclairer à travers le scrotum."

- Comment trouvez-vous l'enfant?
- Alimentation**: type lait, quantités, transit
- Comportement**: joue normalement?
- Croissance et développement**:
 - "A-t-il atteint ses jalons de développement normalement?"
 - Moteur: assis, marche 10-18 mois
 - Social: sourire, séparation
 - Cognitif: permanence objet, puzzles
 - Langage: 1er mot, phrases, 50% compréhensible
 - Vaccins, vitamines K/D
 - Fratrie, contag (crèche)

Pleurs Inhabituels

- Laisser parler+++
- Examen tête aux pieds
- Inspection pampers
- DD selon red-flags:
 - Coliques (le plus fréquent)
 - Psychosocial (dépression post-partum, SBS)
 - Allergies si modification alimentation

Adolescent - HEAADSSS

- H**abitat
- E**ducation
- A**limentation
- A**ctivités
- D**rogues
- S**exualité
- S**anté mentale et **S**uicide
- S**écurité

■ Status Psychiatrique

Anamnèse Psychiatrique

Anamnèse Actuelle

- Explorer plaintes et symptômes
- Contexte (début, durée, évolution)
- Répercussions (social, familial, professionnel)

ATCD Psychiatriques

- Hospitalisation, suivi, traitements
- ATCD familiaux

Questions Spécifiques DD

- Orientation?
- Concentration?
- Idées délirantes?
- Hallucinations?

"Comment trouvez-vous votre enfant aujourd'hui?"

"Quel lait prend-il? Quelle quantité? Combien de selles par jour?"

"Est-ce qu'il joue comme d'habitude? Est-il plus irritable?"

"Comment se passe sa croissance? Suit-il bien les courbes?"

"Avec qui vis-tu? Comment ça se passe à la maison?"

"Comment ça va à l'école? As-tu des amis proches?"

"Comment est ton alimentation? Es-tu satisfait(e) de ton poids?"

"Quels sont tes loisirs? Pratiques-tu un sport?"

"As-tu déjà essayé le tabac, l'alcool ou autre chose?"

"As-tu des questions sur la sexualité? Es-tu en couple?"

"Comment est ton moral? As-tu parfois des idées noires?"

"Te sens-tu en sécurité à la maison et à l'école?"

"Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment?"

"Depuis quand vous sentez-vous ainsi? Qu'est-ce qui a déclenché ces symptômes?"

"Comment cela affecte-t-il votre vie quotidienne? Votre travail? Votre famille?"

"Savez-vous où vous êtes? Quelle date sommes-nous?"

"Avez-vous des difficultés à vous concentrer?"

"Avez-vous des convictions particulières que d'autres ne partagent pas?"

"Entendez ou voyez-vous des choses que les autres ne perçoivent pas?"

• Humeur, anhédonie?

• Anxiété, obsessions?

• Idées suicidaires?

Évaluation Risque Suicidaire (UDR)

• U**rgence: scénario, planification

• D**anger: accessibilité/létalité moyen

• R**isque: FR (ATCD, isolement, substances)

Fonctions Cognitives (MMSE)

1. **Orientation**: date, lieu

2. **Apprentissage**: 3 mots (clé, citron, ballon)

3. **Attention**: calcul 100-7

4. **Rappel**: 3 mots différé

5. **Langage**: nommer, ordres, écriture

6. **Praxie**: copier dessin

■ Anamnèse Sexuelle

Caractériser le Trouble

• Contexte/début

• Fréquence/variations

• Durée/intensité

• Facteurs modifiants

• Conséquences

Contexte

• Partenaire et pratiques

• Intimité

• Désir d'enfants

• Communication couple

Biographie

• Famille, éducation, culture

• Traumatismes

• Développement sexuel

• Expériences

DD Troubles

Désir: anhédonie, hypersexualité, aversion

Excitation: dysfonction érectile, lubrification

Plaisir: anorgasmie, éjaculation précoce/tardive

Douleur: dyspareunie, vaginisme

■ Situations d'Urgence

ABCDE

• A**: Airway - parler, libérer VA ± Guedel ± minerve

• B**: Breathing - inspection, auscultation, oxymétrie, O2

• C**: Circulation - FC, TA, TRC, pouls, voies veineuses

• D**: Disability - GCS, pupilles, hémisyndrome

"Comment est votre humeur? Prenez-vous encore plaisir aux choses?"

"Vous sentez-vous anxieux? Des pensées répétitives?"

"Avez-vous pensé à vous faire du mal?"

"Avez-vous pensé à comment vous le feriez? Avez-vous un plan précis?"

"Avez-vous les moyens à disposition? Médicaments? Armes?"

"Avez-vous déjà fait une tentative? Vivez-vous seul(e)? Consommez-vous de l'alcool ou des drogues?"

"Quel jour sommes-nous? Où sommes-nous?"

"Répétez ces 3 mots: clé, citron, ballon."

"Soustrayez 7 de 100, puis continuez."

"Quels étaient les 3 mots de tout à l'heure?"

"Qu'est-ce que c'est? Suivez cette instruction écrite."

"Copiez ce dessin s'il vous plaît."

"Depuis quand avez-vous ces difficultés? Dans quel contexte ont-elles commencé?"

"À quelle fréquence? Est-ce toujours pareil ou variable?"

"Combien de temps cela dure-t-il? Comment cela affecte-t-il votre vie?"

"Êtes-vous en couple? Comment se passe votre vie intime?"

"Y a-t-il des difficultés dans votre intimité?"

"Avez-vous un désir d'enfant actuellement?"

"Comment communiquez-vous avec votre partenaire sur ces sujets?"

"M'entendez-vous? Pouvez-vous parler?"

"Respirez-vous bien? Je vais vérifier votre respiration."

"Je vérifie votre circulation et vos signes vitaux."

"Ouvrez les yeux. Serrez mes mains."

• E**: Exposure - log-roll, température	"Je vais vous examiner complètement pour vérifier les blessures."
SAMPLE	
• S**ymptômes (caractériser+++)	"Décrivez-moi vos symptômes en détail."
• A**llergies	"Avez-vous des allergies connues?"
• M**édicaments	"Quels médicaments prenez-vous?"
• P**ast-illness & **P**regnancy	"Antécédents médicaux? Êtes-vous enceinte?"
• L**ast meal	"Quand avez-vous mangé pour la dernière fois?"
• E**vents	"Que s'est-il passé exactement?"
Red Flags Généraux	
• FR > 20, SaO2 < 90%	"Patient en détresse respiratoire, oxygène immédiat"
• FC > 100 ou < 50	"Fréquence cardiaque anormale, monitoring continu"
• TA < 90/60	"Patient hypotendu, voie veineuse et remplissage"
• T° > 38° ou < 36°	"Dysrégulation thermique, rechercher sepsis"
• GCS < 12	"Trouble de conscience, protection des voies aériennes"
Urgences Pédiatriques - TEP	
• T**riangle d'Évaluation Pédiatrique	"Évaluation rapide en 30 secondes"
• A**pparence générale	"L'enfant est-il tonique? Consolable? Regard présent?"
• B**reathing	"Respiration normale? Tirage? Bruits anormaux?"
• C**irculation	"Couleur de la peau? Marbrures? TRC?"
■ Communication Thérapeutique	
Entretien Motivationnel	
1. **Demander permission	"Puis-je vous parler de vos habitudes de tabac?"
2. **Explorer connaissances** patient	"Que savez-vous des effets du tabac sur la santé?"
3. **Identifier besoins	"Qu'est-ce qui serait le plus utile pour vous?"
4. **Donner informations** (avec accord)	"Souhaitez-vous que je vous explique les bénéfices de l'arrêt?"
5. **Explorer ambivalence** (avantages/inconvénients)	"Quels sont pour vous les avantages et inconvénients d'arrêter?"
6. **Échelle 0-10** motivation/confiance	"Sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre motivation pour arrêter?"
7. **Plan concret	"Quelle serait la première étape pour vous?"
Annonce Mauvaise Nouvelle	
1. Confort patient	"Êtes-vous bien installé? Souhaitez-vous que quelqu'un soit présent?"
2. "Qu'avez-vous compris?"	"Que savez-vous déjà de votre situation?"
3. Résumé contexte	"Les examens que nous avons faits montrent..."
4. Niveau information souhaité	"Souhaitez-vous que je vous explique en détail?"
5. Annonce progressive	"J'aurais préféré avoir de meilleures nouvelles..."
6. Vérifier compréhension	"Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire?"
7. Explorer ressenti	"Comment vous sentez-vous après ce que je viens de vous dire?"
8. Empathie	"Je comprends que c'est un choc pour vous."
9. Soutien proposé	"Vous ne serez pas seul(e), nous allons vous accompagner."
10. Stratégie suivi	"Voici les prochaines étapes..."
11. Synthèse patient	"Pouvez-vous me dire ce que vous avez compris?"
12. RDV proche + disponibilité	"Je vous revois dans... N'hésitez pas à m'appeler si besoin."

Transmission IPASS • Identification gravité (stable/instable) • Patient (motif, ATCD, évolution) • Actions (à entreprendre, temporalité) • Situations (attention, attitudes) • Synthèse (questions)	
■ Conseils Pratiques ECOS Approche Systématique 1. **Toujours**: saluer, se présenter, demander permission 2. **Anamnèse**: structurée, ne pas oublier question de clôture 3. **Examen**: expliquer avant, patient confortable 4. **Communication**: claire, empathique, vérifier compréhension	<i>"Bonjour, je suis... Puis-je vous examiner?"</i> <i>"Y a-t-il autre chose que je devrais savoir?"</i> <i>"Je vais maintenant... Cela ne devrait pas être douloureux."</i> <i>"Est-ce que mes explications sont claires?"</i>
Pièges Fréquents • Oublier symptômes B • Ne pas caractériser complètement la plainte • Oublier ATCD familiaux • Ne pas explorer psychosocial • Examen incomplet (toujours bilatéral!)	<i>"Toujours demander: "Fièvre? Sueurs? Perte de poids? Fatigue?"</i> <i>"Utiliser LIRQTFS systématiquement"</i> <i>"Y a-t-il des maladies dans votre famille?"</i> <i>"Comment cela affecte-t-il votre vie quotidienne?"</i> <i>"Comparer systématiquement droite et gauche"</i>
Points Clés par Système • CV**: toujours FRCV, pouls périphériques • Pulm**: position assise ET couchée • Abdo**: auscultation AVANT palpation • Neuro**: toujours tester force, réflexes, sensibilité • Locomoteur**: toujours comparer bilatéral • Gynéco**: β-hCG systématique si doute	<i>"Diabète? HTA? Cholestérol? Tabac? Je vais palper tous vos pouls."</i> <i>"Je vais vous ausculter assis puis couché."</i> <i>"J'écoute d'abord, puis je palpe."</i> <i>"Poussez, tirez, sentez-vous ceci?"</i> <i>"Je compare les deux côtés."</i> <i>"Nous allons faire un test de grossesse par précaution."</i>
Mnémotechniques Utiles • LIRQTFS: douleur • TADADAVS: habitudes • HEAADSSS: adolescent • SAMPLE: urgence • UDR: risque suicidaire • IPASS: transmission *Document compilé à partir du résumé ECOS et enrichi avec les informations des PDFs d'anamnèse et examen clinique complets.*	